

SỔ TAY LÂM SÀNG KHÁM BỆNH

BẢNG TRA CỨU LÂM SÀNG: RỄ THẦN KINH & VÙNG CHI PHỐI

Bản đồ định khu vận động (Myotome), cảm giác da (Dermatome) và phản xạ gân xương từ rễ thần kinh cổ C1-C8 đến rễ thần kinh thắt lưng - cùng L1-S5.

1. Đám Rối Thần Kinh Cổ Nông & Sâu (C1 - C4)

Đám rối cổ hình thành từ nhánh trước các dây C1 đến C4, chi phối cảm giác vùng cằm gáy, cổ, ngực trên và vận động cơ hoành hô hấp.

Rễ thần kinh	Vùng cảm giác da (Dermatome)	Cơ vận động chính (Myotome)	Ý nghĩa lâm sàng
C1	Không có vùng cảm giác da riêng	Các cơ dưới cằm xoay ngửa đầu	Đau đầu căng thẳng vùng dưới cằm
C2	Vùng da đỉnh đầu và sau tai (Thần kinh chẩm lớn)	Cơ ức đòn chũm, cơ gối đầu	Đau thần kinh chẩm Arnold (Occipital Neuralgia)
C3	Vùng da bên cổ và góc hàm dưới	Cơ thang, cơ nâng vai	Cơn đau mỗi cơ gáy lan lên thái dương
C4	Vùng da trên xương đòn và đỉnh vai	Dây thần kinh hoành (C3-C5): Chi phối cơ hoành	Tổn thương tủy trên C4 gây ngừng thở tức thì

ĐỊNH LUẬT VÀNG: "C3, C4, C5 GIỮ CHO CƠ HOÀNH ĐẬP"

Trong cấp cứu chấn thương cột sống: Tổn thương tủy sống từ mức C4 trở lên sẽ làm liệt dây thần kinh hoành (Phrenic nerve), khiến bệnh nhân mất hoàn toàn khả năng thở tự nhiên và cần đặt nội khí quản thở máy ngay lập tức.

2. Đám Rối Cánh Tay: Rễ C5, C6, C7, C8 & T1

Tra cứu nhanh vị trí chèn ép rễ thần kinh cổ gây tê bì và yếu cơ tay dựa trên phản xạ và cơ lực đặc hiệu.

Rễ tổn thương	Vị trí đĩa đệm	Vận động yếu (Myotome)	Vùng tê bì (Dermatome)	Phản xạ gân xương
Rễ C5	Đĩa đệm C4 - C5	Dạng cánh tay (Cơ Delta)	Mặt ngoài cánh tay	Phản xạ gân cơ nhị đầu (giảm)
Rễ C6	Đĩa đệm C5 - C6	Gập khuỷu tay, ngửa cẳng tay	Ngón tay cái & ngón trỏ	Phản xạ gân cơ cánh tay quay (giảm)
Rễ C7	Đĩa đệm C6 - C7	Duỗi khuỷu tay (Cơ tam đầu)	Ngón tay giữa	Phản xạ gân cơ tam đầu (giảm)
Rễ C8	Đĩa đệm C7 - T1	Nắm chặt bàn tay, gập ngón	Bờ trong bàn tay & ngón út	Không có phản xạ đặc hiệu
Rễ T1	Đĩa đệm T1 - T2	Dạng & khép các ngón tay	Mặt trong cẳng tay	Không có

NGHIỆM PHÁP SPURLING CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ CỔ

Cho bệnh nhân nghiêng đầu về bên đau, người khám dùng hai tay ấn nhẹ từ trên đỉnh đầu xuống dọc trục cột sống. Nếu xuất hiện cơn đau nhói như luồng điện giật phóng từ cổ xuống các ngón tay tương ứng: Nghiệm pháp Spurling dương tính, khẳng định có chèn ép rễ thần kinh cổ.

3. Đám Rối Thần Kinh Thắt Lưng: Rễ L1, L2, L3 & L4

Đám rối thắt lưng chi phối vận động vùng trước đùi, cơ khoeo háng và cảm giác mặt trước chi dưới.

Rễ thần kinh	Vị trí thoát vị	Cơ vận động chính	Vùng cảm giác da	Nghiệm pháp lâm sàng
Rễ L1 & L2	Khoang T12-L1 & L1-L2	Gập khớp háng (Cơ thắt lưng chậu)	Vùng nếp bẹn và mặt trước trên đùi	Phản xạ cơ biau (ở nam giới)
Rễ L3	Khoang L2 - L3	Duỗi khớp gối (Cơ tứ đầu đùi)	Mặt trước đùi lan chéo xuống gối	Dấu hiệu teo cơ tứ đầu đùi sớm
Rễ L4	Khoang L3 - L4	Gập mu bàn chân (Cơ chày trước)	Mặt trước trong cẳng chân & mắt cá trong	Phản xạ gân bánh chè (Patellar reflex) giảm rõ

TEST KHÁM NHANH RỄ L4: ĐI BẰNG GÓT CHÂN

Yêu cầu bệnh nhân nhấc mũi chân lên và đi bằng gót chân. Nếu bàn chân bên tổn thương bị sụp xuống, không nhấc gót được: Cơ chày trước bị liệt do chèn ép rễ L4.

4. Dây Thần Kinh Tọa: So Sánh Tổn Thương Rễ L5 & S1

Rễ L5 và S1 chiếm tới 90% các ca đau dây thần kinh tọa (Sciatica). Bảng đối chiếu giúp phân biệt chuẩn xác tổn thương trên lâm sàng.

Tiêu chí đánh giá	Tổn thương Rễ L5 (Khoang L4-L5)	Tổn thương Rễ S1 (Khoang L5-S1)
Đường lan của cơn đau	Mặt sau ngoài đùi → Mặt ngoài cẳng chân → Mu bàn chân & Ngón chân cái	Mặt sau đùi → Mặt sau bắp chân → Gót chân, Bờ ngoài bàn chân & Ngón út
Cơ bị yếu / liệt	Cơ duỗi dài ngón cái & Cơ mông nhỏ	Cơ tam đầu cẳng chân (Cơ bắp chuối) & Cơ gấp các ngón
Nghiệm pháp đi lại	Không đi được bằng gót chân	Không đi nhón gót được bằng mũi chân
Phản xạ gân xương	Phản xạ gân cơ chày sau (khó phát hiện)	Phản xạ gân gót Achilles giảm hoặc mất hoàn toàn
Dấu hiệu Trendelenburg	Dương tính (Khung chậu nghiêng do yếu cơ mông nhỏ)	Âm tính

NGHIỆM PHÁP LASÈGUE (NÂNG CHÂN THẲNG - SLR)

Bệnh nhân nằm ngửa, người khám nâng từ từ một chân duỗi thẳng lên. Cơn đau thần kinh tọa bùng phát dọc chân ở góc dưới 60°: Nghiệm pháp Lasègue dương tính. Tiếp tục hạ chân xuống 5° và gấp mu bàn chân (Nghiệm pháp Bragard): Nếu đau tăng vọt, khẳng định 100% rễ thần kinh L5 hoặc S1 đang bị chèn ép cơ học.

5. Hội Chứng Chùm Đuôi Ngựa (S2 - S5): Cấp Cứu Ngoại Khoa

Tủy sống tụt cùng ở đốt L1-L2 bằng nón tủy (Conus medullaris). Phía dưới là các rễ thần kinh tự do trông giống đuôi ngựa, chi phối cơ vòng bàng quang, trực tràng và chức năng sinh dục.

BỘ 3 TRIỆU CHỨNG KINH ĐIỂN CỦA HỘI CHỨNG CHÙM ĐUÔI NGỰA

- 1. Rối loạn tiểu tiện:** Bí tiểu cấp tính (bàng quang căng trướng không tiểu được) hoặc tiểu tiện nhỏ giọt không tự chủ (Overflow incontinence).
- 2. Tê bì mất cảm giác vùng yên ngựa (Saddle anesthesia):** Mất cảm giác hoàn toàn vùng da tiếp xúc với yên ngựa khi cưỡi (vùng quanh hậu môn, cơ quan sinh dục ngoài và mặt trong đùi trên).
- 3. Mất trương lực cơ thắt hậu môn:** Khám trực tràng thấy cơ thắt giãn rộng, không co bóp theo ý muốn.

THỜI GIAN VÀNG CAN THIỆP PHẪU THUẬT: TRƯỚC 48 GIỜ

Hội chứng chùm đuôi ngựa do đĩa đệm thoát vị khối lớn vỡ rời vào ống sống là một trong những **cấp cứu ngoại thần kinh tối khẩn cấp**. Phẫu thuật mổ giải ép lấy nhân nhầy trong vòng 24 - 48 giờ đầu tiên quyết định bệnh nhân có hồi phục được khả năng tự chủ tiểu tiện hay phải mang ống thông tiểu suốt đời.